Insuficiencia mitral y aórtica

FISIOPATOLOGIA · Clase 12 · la válvula que no cierra: del reflujo a la sobrecarga de volumen

1 · LA VÁLVULA QUE NO CIERRA: DOS REFLUJOS

Insuficiencia valvular
cierre incompleto de la válvula: parte del volumen latido vuelve hacia atrás

si es mitral, el reflujo es en sístole

si es aórtica, el reflujo es en diástole

F1 — **Insuficiencia mitral**
en sístole la sangre vuelve del VI a la AI; el volumen latido se reparte en anterógrado y regurgitante

F9 — **Insuficiencia aórtica**
en diástole la sangre vuelve de la aorta al VI; la válvula debe cerrar en diástole

daña la válvula y produce

devuelve sangre a la AI y p

devuelve sangre al VI y produce

Sobrecarga de volumen
la cavidad que recibe de más se dilata: AI y VI en la mitral, VI en la aórtica

su volumen depende de la

en la mitral hace subir la

2 · INSUFICIENCIA MITRAL: DEL REFLUJO A LA FALLA DERECHA

F2 — **Causas mitrales**
fiebre reumática (válvula rígida y engrosada), infarto con disfunción o rotura del papilar, endocarditis, cardiomiopatía dilatada

si es gradual (fiebre reumática)

F3 — **Soplo sistólico**
de regurgitación en el foco mitral, irradiado a la axila; la punta se desplaza abajo y afuera

F4 — **Pulso pequeño y PA convergente**
llega menos sangre a la aorta: diferencial menor de 40 mmHg

al llegar menos sangre a la aorta da

daña la válvula y produce

con el pulso pequeño orienta a

con el soplo orienta a

al cerrar mal en sístole se oye el

Soplo sistólico a la axila + pulso pequeño + PA convergente: insuficiencia mitral

Sube la presión de la AI
se transmite hacia atrás a las venas y los capilares pulmonares

se transmite a los capilares y causa

Congestión venocapilar pulmonar
sale líquido al intersticio y a los alvéolos: disnea

si se mantiene por años produce

si aumenta el reflujo, ensancha la

F5 · F8 — **Hipertensión pulmonar**
el VD vence más resistencia, se hipertrofia y claudica

con los años lleva a la

obliga al VD a vencer más presión hasta

F5 · F8 — **Falla del VD**
la sangre se estanca en las venas sistémicas: edema, ascitis y hepatomegalia

se manifiesta como

Insuficiencia cardiaca congestiva (izquierda y derecha) si no se corrige la válvula

3 · AGUDA FRENTE A CRÓNICA

F7 — **Instalación crónica** (fiebre reumática, endocarditis)
AI y VI se dilatan y compensan la sobrecarga de volumen

tras años de compensar da

F7 — **Síntomas tardíos**
muchos pacientes están asintomáticos; la falla izquierda (disnea de esfuerzo, ortopnea, DPN, palpitaciones, tos) llega a los 6-10 años

F2 · F7 — **Instalación brusca** (infarto, papilar roto)
la AI no se adapta y la presión se dispara: rápida congestión pulmonar

sin tiempo para adaptarse termina en

no hay adaptación y llega al

F11 · F21 — **Edema agudo de pulmón**
sube la presión en VI, AI y capilar pulmonar: urgencia

si es súbita (infarto, papilar roto)

si progresa se complica con

4 · INSUFICIENCIA AÓRTICA: CAUSAS Y REFLUJO

F10 — **Causas aórticas**
fiebre reumática (la más común), endocarditis, sífilis terciaria, válvula bicúspide, disección de aorta y trauma

si es súbita (trauma, disección)

si es gradual (fiebre reumática)

F11 — **Insuficiencia aórtica aguda**
trauma o disección: reflujo masivo súbito a un VI no adaptado

Insuficiencia aórtica crónica
inicio gradual: sobrecarga de volumen y de presión; el VI se dilata e hipertrofia; por años solo un soplo diastólico

por ejemplo, en un

deja oír el

F21 — **Caso**
accidente de tránsito con dolor torácico, disnea extrema, soplo diastólico y PA 100/40: IAo aguda con edema agudo

F15 — **Soplo diastólico aspirativo**
en el foco aórtico, irradiado a la punta; la punta se desplaza abajo y afuera (7.º espacio, axila)

con gran eyección produce la

se suma a la

5 · PRESIÓN DIFERENCIAL AMPLIA Y SIGNOS PERIFÉRICOS

F20 — **Presión diferencial amplia**
gran eyección sistólica + fuga diastólica: PAS alta y PAD muy baja

se expresa como la

hace visibles los signos de

da el pulso en

F12 — **PA típica 140/20 mmHg**
diferencial de unos 120; puede ir de 150/50 a 150/0

F13 — **Pulso en martillo de agua**
sube rápido con la gran eyección y cae rápido por la fuga diastólica

F14 — **Musset y Quincke**
cabeza que asiente con cada latido; uña que alterna rubor y palidez; también danza arterial (carótidas visibles)

forma parte de la

forma parte de la

forma parte de la

Insuficiencia aórtica crónica: soplo diastólico + PA divergente + signos periféricos que derivan de la presión diferencial amplia

6 · QUÉ CAMBIA EL REFLUJO Y POR QUÉ DUELE EL PECHO

F17 — **Qué modifica el reflujo**
aumentan: FC baja (diástole larga) y resistencia periférica alta; reducen: taquicardia y baja resistencia

F16 — **Robo coronario**
las coronarias se llenan en diástole; con PAD baja perfunden mal y el VI hipertrófico pide más O2

con la PAD muy baja produce

con el VI hipertrófico causa

Angina
dolor torácico sin coronariopatía obstructiva

F19 — **Falla del VI**
el VI recibe volumen de más, crece y al final claudica: disnea y ortopnea; la PAD baja reduce el flujo coronario

es la

se suma a la

Insuficiencia cardiaca izquierda y angina: complicaciones de la IAo crónica

se alivia con

7 · DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

F6 — **Tratamiento de la mitral**
para la congestión: bajar precarga y poscarga (IECA, diuréticos); avanzada: digitálicos

si es avanzada, el definitivo es el

Recambio valvular
tratamiento quirúrgico definitivo (prótesis biológica o metálica)

se confirma con el

F18 — **Ecocardiograma**
prueba clave: muestra el reflujo de la aorta al VI tras el cierre valvular

ECG y radiografía
hipertrofia del VI con sobrecarga diastólica; cardiomegalia por dilatación del VI y de la aorta proximal

se ve en ECG y radiografía como

apoya el

muestra el reflujo y define el

Reflujo confirmado y valvulopatía definida: se decide la conducta según gravedad

concepto · mecanismo · causa · signo · complicación · desenlace · síntoma · ejemplo · diagnóstico · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clases 14 y 15 · Dr. Solito — teoría del docente (= literatura)